

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

TEST DE MORISKY-GREEN-LEVINE (MGL / MMAS-4)

Morisky Medication Adherence Scale (Morisky, Green & Levine, 1986) · Validación Española (Val Jiménez et al., 1992)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Test de Morisky-Green-Levine para la Valoración de la Adherencia Farmacológica (MMAS-4)
Sigla / Acrónimo	MGL o MMAS-4 (Morisky 4-Item Scale)
Autoría original	Donald E. Morisky, Lawrence W. Green & David M. Levine (Johns Hopkins / UCLA, 1986)
Adaptación en español	Val Jiménez, Amorós, Martínez et al. (1992, Aten Primaria); Rodríguez-Chamorro et al. (2008)
Constructo evaluado	Conducta de cumplimiento terapéutico y factores determinantes del incumplimiento voluntario o involuntario
Población diana	Pacientes adultos con tratamientos farmacológicos crónicos (hipertensión, diabetes, dislipemia, psicofármacos)
Tiempo de aplicación	1 a 2 minutos (administrado por médico o personal de enfermería / farmacéutico)
Estructura y formato	4 preguntas dicotómicas (Sí / No) de rápida formulación en la anamnesis habitual
Condiciones de uso	Uso en práctica clínica asistencial; las escalas de la familia Morisky están sujetas a derechos registrados

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico constituye uno de los problemas más graves de la medicina moderna: se estima que en países desarrollados más del 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no toman sus medicamentos según la prescripción médica, lo que resulta en fracasos terapéuticos aparentes, ingresos hospitalarios evitables, escaladas innecesarias de dosis y un elevado gasto sanitario.

El Test de Morisky-Green-Levine fue concebido como un instrumento clinimétrico ultra-breve basado en el principio de que los pacientes suelen experimentar dificultades para admitir su falta de cumplimiento ante el médico. Por ello, las preguntas fueron redactadas de manera no incriminatoria, explorando tanto las omisiones involuntarias (olvidos cotidianos o falta de puntualidad horaria) como las omisiones voluntarias deliberadas (suspensión del fármaco al encontrarse bien o al experimentar molestias secundarias).

3. LAS 4 PREGUNTAS CLÍNICAS DEL TEST DE MORISKY-GREEN

Ítem	Pregunta Clínica Estructurada	Respuesta	Tipo de Incumplimiento Evaluado
1	¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos para su problema?	No = 0 / Sí = 1	Incumplimiento involuntario por fallo de memoria o descuido
2	¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?	Sí = 0 / No = 1	Cumplimiento de la posología y regularidad cronofarmacológica
3	Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar la medicación?	No = 0 / Sí = 1	Incumplimiento voluntario por sensación de curación aparente
4	Si alguna vez le sienta mal, ¿deja de tomarla?	No = 0 / Sí = 1	Incumplimiento voluntario por evitación de efectos adversos

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA ESPAÑOLA

Sensibilidad diagnóstica	Sensibilidad del 52 — 60% para detectar no-adherencia frente a métodos objetivos (recuento de comprimidos o registros de dispensación electrónica en farmacia).
Especificidad diagnóstica	Elevada especificidad (80 — 90%); cuando un paciente reconoce que incumple, la probabilidad de que realmente sea no adherente es casi certera.
Valor predictivo positivo	VPP del 75 — 85% en atención primaria y consultas especializadas de hipertensión y dislipemia.
Consistencia interna	Alfa de Cronbach $\alpha = 0.61 - 0.68$, adecuado para una escala ultra-corta de 4 ítems dicotómicos heterogéneos.
Validez predictiva	El cumplimiento estricto predice significativamente el control de la presión arterial ($< \frac{140}{90}$ mmHg, OR = 2.4) y de la hemoglobina glicosilada (HbA1c < 7.0%).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Patrón de adherencia estricta	El paciente se clasifica como ADHERENTE si y solo si responde de forma correcta a las 4 preguntas: NO a la 1, SÍ a la 2, NO a la 3 y NO a la 4.
Criterio de no adherencia	Cualquier respuesta incorrecta (responder “Sí” a los olvidos o a dejar la medicación, o “No” a la toma horaria) clasifica al paciente de inmediato como NO ADHERENTE (o mal cumplidor).
Puntuación continua	Se puede contabilizar el número de fallos de 0 a 4 (0 = cumplimiento perfecto; 1-4 = grados crecientes de incumplimiento).
Actitud en la entrevista	El profesional debe formular las preguntas de forma neutral y empática, evitando el tono sancionador para favorecer la sinceridad del paciente.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Proporción	Clasificación	Significación Clínica y Acción Recomendada
4 aciertos (0 fallos)	45 - 55%	Adherente / Buen Cumplidor	Tratamiento tomado adecuadamente. Mantener refuerzo positivo.
1 fallo	25 - 30%	No Adherente Leve / Ocasional	Generalmente olvidos esporádicos; implementar sistemas de aviso.
2 fallos	12 - 15%	No Adherente Moderado	Incumplimiento deliberado o desorganización; revisar pauta.
3 - 4 fallos	5 - 10%	No Adherente Severo	Abandono terapéutico encubierto; riesgo inminente de descompensación.

PUNTO DE CORTE CANÓNICO:

- **Menos de 4 respuestas óptimas (≥ 1 fallo):** Clasificación formal como **No Adherente**. Ante un paciente con hipertensión o diabetes no controlada y MGL alterado, **está contraindicado aumentar la dosis o añadir un segundo fármaco** sin resolver primero la causa del incumplimiento.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE MANEJO DE LA NO-ADHERENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Paso 1: Aplicación sistemática del MGL: Formular las 4 preguntas ante cualquier revisión médica o mal control biológico.

Paso 2: Si el Paciente es Adherente (0 fallos) pero Persiste Mal Control: Explorar resistencia farmacológica real, dosificación subterapéutica o factores dietéticos/metabólicos.

Paso 3: Si Hay Fallos en Ítems 1 o 2 (Olvidos / Desorganización Horaria):

- Simplificar la pauta a monodosis diaria matutina si es posible o utilizar combinaciones a dosis fijas en un solo comprimido.
- Indicar uso de pastilleros semanales tipo SPD (Sistema Personalizado de Dosificación) o alarmas en el teléfono móvil.

Paso 4: Si Hay Fallos en Ítem 3 (Deja la medicación al sentirse bien): Explicar el carácter asintomático y crónico de la patología (la hipertensión es un "enemigo silencioso").

Paso 5: Si Hay Fallos en Ítem 4 (Deja la medicación por efectos secundarios): Explorar disfunción eréctil, mareo, tos o edemas; cambiar de familia farmacológica sin culpabilizar al paciente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN MEDICINA DE FAMILIA

Identificación: Varón de 58 años con hipertensión arterial diagnosticada hace 3 años, en tratamiento con amlodipino 10 mg/día. En revisiones sucesivas presenta cifras de 158/98 mmHg. El médico contemplaba asociar un segundo antihipertensivo.

Evaluación MGL:

- Ítem 1 (Olvidos): "No".
- Ítem 2 (Horarios): "Sí".
- Ítem 3 (Deja si está bien): "Sí, como no me duele la cabeza pienso que no lo necesito todos los días".
- Ítem 4 (Deja si le sienta mal): "Sí, cuando noto hinchazón en los tobillos descanso 4 o 5 días".

Resultado: 2 fallos (No Adherente Moderado Voluntario). La aparente refractariedad tensional era un falso fracaso terapéutico por incumplimiento.

Intervención: En lugar de aumentar medicación, se sustituyó el amlodipino por un ARA-II (losartán/hidroclorotiazida) para eliminar el edema maleolar, y se le explicó la necesidad de tratamiento continuo ininterrumpido.

Seguimiento a las 6 semanas: El MGL alcanzó los 4 aciertos (**Adherente estricto**), con tensión arterial controlada en 126/80 mmHg.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos de Toxicidad:

- **Hipotensión / Hipoglucemia por Reanudación:** Si un paciente no adherente reinicia bruscamente dosis altas que tenía prescritas tras semanas de abandono, puede sufrir shock o coma hipoglucémico.
- **Pseudoresistencia Terapéutica:** Escalar dosis en un paciente no adherente puede causar intoxicación aguda cuando decide tomar los fármacos acumulados.

Diagnóstico Diferencial:

- **Falso Cumplimiento:** Un resultado adherente en MGL puede ser falso positivo por miedo a defraudar al médico; contrastar con retiradas en farmacia.
- **Deterioro Cognitivo Inicial:** Olvidos frecuentes en ancianos que superan la despistabilidad ordinaria exigen cribado de demencia con MEC/MMSE.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Morisky, D. E., Green, L. W., & Levine, D. M. (1986). Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. *Medical Care*, 24(1), 67-74. <https://doi.org/10.1097/00005650-198601000-00007>
- Val Jiménez, A., Amorós Ballester, G., Martínez Visa, P., Rosell Abellana, M., & Morera Porras, J. (1992). Estudio descriptivo del cumplimiento terapéutico en la hipertensión arterial y validación del test de Morisky y Green. *Atención Primaria*, 10(5), 767-770.
- Rodríguez-Chamorro, M. A., García-Jiménez, E., Amariles, P., Rodríguez-Chamorro, A., & Faus, M. J. (2008). Revisión de tests de medición del cumplimiento terapéutico utilizados en la práctica clínica. *Atención Primaria*, 40(8), 413-417.
- Morisky, D. E., Ang, A., Krousel-Wood, M., & Ward, H. J. (2008). Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. *The Journal of Clinical Hypertension*, 10(5), 348-354.